

WIREFRAME FUNCIONAL

Portal Familiar

Plataforma asistencial y de comunicación con familias

Campo	Definición
Versión	v0.1 · Documento consolidado para prototipo
Fecha	27 de agosto de 2026
Base funcional	PRD v0.2 + Wireframes Auxiliar, Enfermería y Medicina + AGENTS.md v1.1 + decisiones cerradas durante la revisión del Portal Familiar
Ámbito	Residencias geriátricas · prototipo con datos ficticios
Estado	Cerrado funcionalmente para construir el prototipo navegable
Usuario	Familiar autorizado de uno o varios residentes

Principio rector

El Portal Familiar no es una historia clínica para familiares. Su finalidad es permitir que una persona previamente autorizada consulte en un entorno privado y autenticado exclusivamente información específicamente preparada para ella, redactada en lenguaje comprensible y aprobada por el profesional competente.

La familia no accede directamente a observaciones internas, valoraciones de Enfermería o Medicina, constantes, indicaciones, seguimientos, estado basal, informes de derivación, escalados, líneas temporales ni historial clínico.

La unidad de información del portal es la publicación familiar, no el evento asistencial interno que la originó.

1. Decisiones funcionales cerradas

Decisión	Definición funcional
Autorización	Administración gestiona las autorizaciones familiares.
Acceso	Solo una autorización vigente permite consultar información del residente.
Contenido	La familia consulta exclusivamente publicaciones familiares aprobadas y publicadas.
Separación	Registro asistencial interno y publicación familiar son objetos distintos.
Aprobación	Ningún contenido sanitario se publica sin aprobación humana previa.
Responsable	Aprueba el profesional que cierra el circuito: Enfermería cuando resuelve el evento o Medicina cuando es el punto final.

Frecuencia ordinaria	Configurable por residente: diaria, semanal o solo actualizaciones relevantes.
Programación	Una publicación ya aprobada se publica automáticamente cuando corresponde; no depende de que un profesional recuerde enviarla.
Hora	Cada centro configura las horas de publicación ordinaria.
Actualización relevante	Se publica tras aprobación independientemente de la frecuencia ordinaria.
Histórico visible	Publicaciones ordinarias visibles durante 30 días.
Relevantes	Actualizaciones relevantes visibles durante 6 meses.
Conservación interna	Los 30 días/6 meses son reglas de visualización del portal, no la política jurídica definitiva de conservación.
Email	Eliminado del piloto.
Push	No se implementan notificaciones push en v0.1.
Urgencias	Una derivación urgente genera actualización relevante y exige documentar intento de llamada al contacto familiar designado, sin retrasar la asistencia.
Corrección	Una publicación ya publicada no se edita ni se sobrescribe.
Error posterior	Se crea una nueva publicación correctora vinculada a la original.
Retirada excepcional	Solo por privacidad, seguridad, audiencia/residente incorrecto u otra causa excepcional justificada y auditada.
Profesional visible	Se muestra «Información publicada por el equipo asistencial del centro».
Descarga	No existe botón específico de descarga en v0.1.
Mensajería	No existe chat, comentarios ni respuesta directa a publicaciones.
Citas	El familiar puede solicitar una cita presencial estructurada con equipo médico o Enfermería.
Historial clínico	Familia no accede al Historial de eventos ni a la línea temporal interna.

2. Tipos de publicaciones familiares

2.1 Resumen del día

Comunicación ordinaria cuando la frecuencia configurada sea diaria.

2.2 Resumen semanal

Comunicación ordinaria cuando la frecuencia configurada sea semanal.

2.3 Actualización relevante

Comunicación independiente de la frecuencia ordinaria destinada a trasladar un hecho que el profesional considera suficientemente importante para no esperar al siguiente resumen.

No utilizar externamente términos internos como evento prioritario, escalado, protocolo urgente, seguimiento, cierre médico o indicación.

3. Criterio de «Actualización relevante»

La plataforma no decide automáticamente qué acontecimientos son clínicamente relevantes. La clasificación corresponde al profesional que prepara o aprueba la comunicación.

- Un cambio significativo respecto a la situación habitual que deba conocer la familia.
- Una incidencia relevante.
- Una caída o lesión que el profesional considere necesario comunicar específicamente.
- Una alteración clínica que requiera seguimiento especial.
- Un cambio relevante en la atención habitual.
- Una situación que requiera participación o conocimiento específico de la familia.
- Una derivación a Urgencias.

Regla especial: toda derivación a Urgencias debe generar una Actualización relevante, además del circuito de contacto telefónico. No se publicará automáticamente el texto clínico del evento.

4. Frecuencia y automatización de publicación

Cada residente tendrá configurada una modalidad ordinaria: Diaria, Semanal o Solo actualizaciones relevantes.

La hora o día de publicación será configurable por el centro. Una vez que el profesional haya aprobado la publicación, el sistema se encarga de hacerla visible automáticamente en el momento configurado.

Automatizar la publicación no equivale a automatizar la redacción o aprobación. Si a la hora programada no existe una publicación aprobada, el sistema no inventa información ni publica automáticamente frases como «todo bien».

Las Actualizaciones relevantes pueden publicarse inmediatamente después de su aprobación.

5. Estados

5.1 Autorización familiar

- Pendiente
- Activa
- Suspendida
- Revocada
- Caducada

Solo el estado Activa permite acceder.

5.2 Publicación

- Borrador
- Aprobada
- Preparada para publicación

- Publicada
- Publicación correctora
- Retirada excepcional

Una publicación ordinariamente publicada pasa a considerarse inmutable.

5.3 Solicitud de cita

- Pendiente de gestión
- Propuesta por el centro
- Confirmada
- Solicitud de cambio
- Cancelada
- Finalizada

FAM-01. Acceso

Objetivo: Permitir acceso únicamente a usuarios autenticados.

CENTRO RESIDENCIAL X

Portal para familias

ACCEDER AL PORTAL

Correo electrónico

[_____]

Contraseña

[_____]

[ACCEDER]

¿Ha olvidado su contraseña?

- Cuenta individual.
- La cuenta no concede por sí misma acceso a ningún residente.
- Autorización comprobada en servidor.
- Gestión segura de sesión.
- Segundo factor según política definitiva.
- No revelar mediante errores si una cuenta determinada existe.

FAM-02. Segundo factor

Objetivo: Completar el acceso cuando la política de seguridad lo requiera.

VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD

Introduzca el código de verificación.

[_ _ _ _ _]

[VERIFICAR]

- El mecanismo técnico definitivo se resolverá antes de producción.

FAM-03. Selección de residente

Objetivo: Resolver los casos con más de una autorización activa.

PERSONAS AUTORIZADAS

Selecione de quién desea consultar información.

MARÍA GARCÍA
Centro Residencial X
[VER INFORMACIÓN]

JOSÉ GARCÍA
Centro Residencial X
[VER INFORMACIÓN]

[MI CUENTA] [SALIR]

- Si existe una sola autorización activa, esta pantalla se omite.
- Solo aparecen autorizaciones activas.
- No se muestran otros familiares autorizados.
- No se muestran identificadores internos.
- No se accede a otro residente manipulando URL o identificadores.

FAM-04. Inicio del residente

Objetivo: Mostrar de forma sencilla la información familiar reciente.

CENTRO RESIDENCIAL X
Portal para familias

MARÍA GARCÍA

Hola, Ana.

ACTUALIZACIONES DE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

24 AGOSTO · RESUMEN DEL DÍA
María ha pasado el día tranquila...
[LEER]

21 AGOSTO · ACTUALIZACIÓN RELEVANTE
Durante la tarde...
[LEER]

18 AGOSTO · RESUMEN DEL DÍA
...
[LEER]

[VER TODAS LAS ACTUALIZACIONES]

Frecuencia habitual: diaria

[SOLICITAR CITA PRESENCIAL]

[MI CUENTA] [SALIR]

- Se muestran publicaciones ordinarias de los últimos 30 días.
- Las Actualizaciones relevantes pueden permanecer visibles durante 6 meses.
- Orden cronológico inverso.
- El contenido procede exclusivamente del texto familiar aprobado.
- No aparecen borradores ni publicaciones pendientes.
- No aparecen datos clínicos internos automáticamente.

FAM-05. Historial visible de actualizaciones

Objetivo: Revisar publicaciones anteriores sin convertir la pantalla en una historia clínica.

< Inicio

ACTUALIZACIONES DE MARÍA

24 AGOSTO

Resumen del día

[ABRIR]

21 AGOSTO

Actualización relevante

[ABRIR]

18 AGOSTO

Resumen del día

[ABRIR]

ACTUALIZACIONES RELEVANTES ANTERIORES

12 JULIO

Actualización relevante

[ABRIR]

- Publicaciones ordinarias: 30 días.
- Actualizaciones relevantes: 6 meses.
- Una actualización relevante dentro de los últimos 30 días no se duplica.
- No existe búsqueda por diagnóstico, profesional o categoría clínica.
- No constituye el Historial asistencial del residente.

FAM-06. Detalle de publicación

Objetivo: Leer una comunicación completa manteniendo un contexto sencillo.

< Actualizaciones

MARÍA GARCÍA

RESUMEN DEL DÍA

24 de agosto de 2026

Hoy María ha pasado un día tranquilo.

Ha realizado las comidas adecuadamente y ha participado durante la mañana en las actividades habituales.

Por la tarde ha estado algo más cansada, pero posteriormente se ha encontrado tranquila.

Seguiremos pendientes de su evolución.

Información publicada por el equipo asistencial del centro.

[VOLVER]

- Solo puede mostrarse el texto exacto aprobado para la familia.
- No se incorporan automáticamente observaciones, valoraciones, constantes, indicaciones, diagnósticos, escalados, seguimientos, tareas, línea temporal, etiquetas de prioridad ni notas internas.

FAM-07. Sin publicaciones recientes

Objetivo: Evitar que la ausencia de contenido se interprete como una valoración clínica.

MARÍA GARCÍA

ACTUALIZACIONES

Actualmente no hay nuevas publicaciones disponibles en este periodo.

La información aparecerá aquí cuando haya sido preparada y publicada por el centro.

[VOLVER]

- No utilizar «Todo está bien», «No existen incidencias» o «El residente está estable».
- No tener publicaciones disponibles no permite inferir una situación clínica.

FAM-08. Resumen diario/semanal

Objetivo: Publicar automáticamente una comunicación previamente aprobada cuando llegue el momento configurado.

RESUMEN SEMANAL

Semana del 17 al 23 de agosto de 2026

[texto familiar aprobado]

Publicado: 24/08/2026

- El familiar no realiza ninguna acción especial.
- La publicación solo aparece si existe un texto previamente aprobado.

FAM-09. Actualización relevante

Objetivo: Publicar información relevante sin esperar al resumen ordinario.

ACTUALIZACIÓN RELEVANTE

24 de agosto de 2026

[texto específicamente redactado
y aprobado para la familia]

[VOLVER]

- Independiente de la frecuencia ordinaria.
- Puede publicarse inmediatamente después de aprobación.
- Permanece visible durante 6 meses.
- La condición «relevante» la decide el profesional.
- No implica automáticamente gravedad clínica.

FAM-10. Derivación urgente y contacto familiar

Objetivo: evitar que una publicación digital sustituya la comunicación directa cuando existe una derivación urgente.

DERIVACIÓN A URGENCIAS

|
+-- asistencia / traslado continúa
+-- preparar Actualización relevante
+-- aprobación profesional
+-- publicación en Portal Familiar
+-- llamada al contacto familiar designado

- La comunicación familiar nunca retrasa la atención urgente ni el traslado.
- Debe existir un contacto familiar designado para este circuito según configuración/autorización.
- Se documenta persona a la que se intenta contactar, fecha/hora y resultado: contactado / no contactado.
- Si no responde, queda registrado el intento.
- La política sobre nuevos intentos la define el centro.
- La llamada no sustituye la publicación familiar ni viceversa.

FAM-11. Corrección de una publicación publicada

Principio: lo publicado no se edita retrospectivamente.

PUBLICACIÓN ORIGINAL

24/08/2026

[permanece visible]

+

CORRECCIÓN

25/08/2026

Corrección de la actualización publicada el 24/08/2026:

[texto correcto]

[ABRIR PUBLICACIÓN ORIGINAL]

- La publicación original permanece.
- La nueva publicación identifica claramente que es una corrección.
- Ambas quedan vinculadas.
- Se conserva trazabilidad interna de autor, aprobador y fechas.
- No existe botón «Editar publicación publicada».

FAM-12. Retirada excepcional

No se utiliza para corregir errores ordinarios. Solo puede existir ante circunstancias excepcionales como publicación correspondiente a otro residente, audiencia familiar equivocada, brecha de confidencialidad, información que no debía ser accesible o incidente de seguridad equivalente.

24 AGOSTO

Esta actualización ya no está disponible.

- El contenido deja de ser visible.
- La referencia permanece.
- El original permanece íntegro en auditoría interna.
- Retirada, motivo, usuario y fecha quedan registrados.
- Requiere permiso específico.
- No puede utilizarse para «limpiar» errores clínicos o mejorar retrospectivamente la redacción.

FAM-13. Solicitar cita presencial

Objetivo: permitir al familiar solicitar una conversación más profunda sin crear un chat clínico.

SOLICITAR CITA PRESENCIAL

¿Con qué equipo desea hablar?

- () Enfermería
() Equipo médico

Motivo

- () Resolver dudas sobre la situación actual
() Comentar cuidados o evolución
() Revisar información recibida
() Otro

Comentario breve - opcional

[_____]

Disponibilidad aproximada

☐ Mañana

☐ Tarde

Días preferentes - opcional

[_____]

[ENVIAR SOLICITUD]

Aviso visible: Esta solicitud no es un canal de atención urgente. Ante una situación urgente utilice los canales establecidos por el centro.

- No se selecciona un profesional concreto.
- La solicitud se dirige al equipo médico o Enfermería.
- El centro decide qué profesional realizará la reunión.
- No existe conversación libre dentro de la solicitud.
- El campo de texto es breve y no pretende sustituir una valoración.
- La solicitud queda registrada con usuario y fecha/hora.
- El destinatario interno definitivo se configurará en el futuro perfil de Administración/Dirección.

FAM-14. Seguimiento de cita

MIS SOLICITUDES

CITA CON EQUIPO MÉDICO

Solicitada: 27/08/2026

Estado:

PROPUESTA DEL CENTRO

Martes 1 de septiembre

17:00

[ACEPTAR CITA]

[SOLICITAR OTRO HORARIO]

[CANCELAR SOLICITUD]

- Si acepta, pasa a Cita confirmada.
- Si solicita otro horario, vuelve al centro como solicitud estructurada.
- No se habilita chat.

FAM-15. Autorización no activa

ACCESO NO DISPONIBLE

Actualmente no dispone de autorización activa para consultar esta información.

Si considera que se trata de un error, contacte con el centro por sus canales habituales.

[VOLVER]

La autorización se aplica en servidor.

FAM-16. Mi cuenta

MI CUENTA

Ana García

ana*****@email.com

SEGURIDAD

[CAMBIAR CONTRASEÑA]

[GESTIONAR SEGUNDO FACTOR]

[CERRAR TODAS LAS SESIONES]

INFORMACIÓN

[AVISO DE PRIVACIDAD]

[CERRAR SESIÓN]

No permite modificar autorizaciones, consultar otros familiares, modificar datos clínicos, cambiar frecuencia de publicación, seleccionar profesionales ni gestionar información asistencial.

FAM-17. Cambio entre residentes

MARÍA GARCÍA

[CAMBIAR]

() María García

() José García

[CONTINUAR]

Cada acceso vuelve a comprobar los permisos en servidor.

FAM-18. Sesión caducada y error técnico

SU SESIÓN HA FINALIZADO

Por seguridad debe volver a identificarse.

[VOLVER A ACCEDER]

NO PODEMOS MOSTRAR LA INFORMACIÓN
EN ESTE MOMENTO

Se ha producido un problema técnico.

[REINTENTAR]

Nunca presentar un fallo técnico como ausencia de información clínica.

6. Notificaciones externas

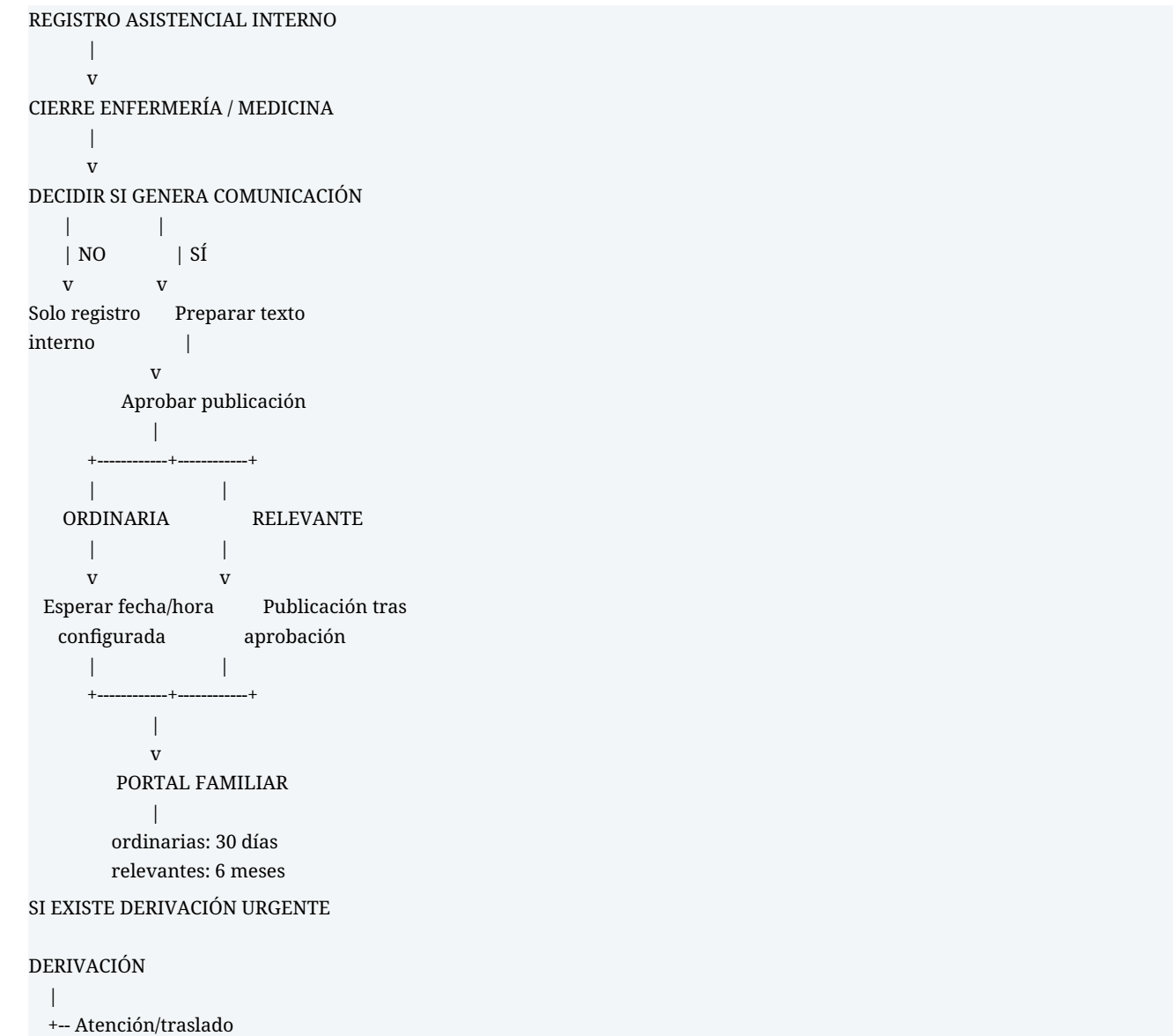
Decisión v0.1

- No emails de nuevas publicaciones.
- No SMS.
- No WhatsApp.
- No notificaciones push.

El familiar consulta directamente el Portal Familiar. Las Actualizaciones relevantes quedan destacadas dentro del portal. Cuando exista una situación que requiera comunicación directa inmediata, como una derivación urgente, se utiliza el contacto telefónico documentado definido en FAM-10.

Las notificaciones push genéricas podrán reevaluarse como funcionalidad futura si las pruebas con familias demuestran utilidad real.

7. Flujo funcional consolidado



+-- Actualización relevante

+-- Llamada familiar documentada

8. Límites del familiar

Puede

- Iniciar sesión y completar controles de seguridad.
- Consultar residentes autorizados.
- Leer publicaciones aprobadas.
- Consultar publicaciones ordinarias recientes.
- Consultar Actualizaciones relevantes durante su periodo visible.
- Consultar correcciones.
- Solicitar cita presencial con Enfermería o equipo médico.
- Consultar y aceptar una propuesta de cita.
- Gestionar aspectos de seguridad de su propia cuenta.
- Cerrar sesión.

No puede

- Acceder al registro cotidiano interno.
- Acceder a observaciones de Auxiliar.
- Acceder a valoraciones de Enfermería o Medicina.
- Consultar constantes automáticamente.
- Consultar basal, Barthel, CFS o GDS.
- Consultar Historial clínico o línea temporal.
- Consultar seguimientos o indicaciones médicas.
- Acceder automáticamente al informe de derivación.
- Editar publicaciones.
- Modificar autorizaciones o frecuencia.
- Consultar otros familiares autorizados.
- Enviar mensajes clínicos.
- Utilizar el portal como canal de urgencias.
- Elegir qué profesional concreto debe atender una cita.

9. Seguridad y privacidad

Toda consulta debe comprobar en servidor: usuario + centro + residente + autorización activa + audiencia + publicación.

- Cambiar una URL nunca concede acceso.
- No utilizar identificadores sanitarios en URL.
- No incluir contenido clínico completo en logs.
- Una revocación de autorización debe surtir efecto incluso con sesión previamente abierta.
- Sin publicidad, píxeles de marketing, grabaciones de sesión ni analítica invasiva.
- Solo cookies necesarias.
- Interfaz responsive y objetivo WCAG 2.2 AA.
- Únicamente datos ficticios durante prototipo.

10. Criterios de aceptación

- ☐ Familiar no autenticado no accede.
- ☐ Solo autorización activa concede acceso.
- ☐ Un usuario no accede a otro residente manipulando identificadores.
- ☐ Familia solo ve publicaciones aprobadas y publicadas.
- ☐ Borradores y publicaciones pendientes nunca aparecen.
- ☐ Contenido clínico interno no se copia automáticamente.
- ☐ Publicaciones ordinarias permanecen visibles 30 días.
- ☐ Actualizaciones relevantes permanecen visibles 6 meses.
- ☐ No existe email, SMS, WhatsApp ni push en v0.1.
- ☐ Hora y frecuencia ordinaria son configurables por centro/residente.
- ☐ Publicaciones aprobadas se publican automáticamente al alcanzar el momento configurado.
- ☐ El sistema no genera contenido clínico para cubrir una publicación ausente.
- ☐ Actualización relevante puede publicarse tras aprobación.
- ☐ La decisión de relevancia corresponde al profesional.
- ☐ Derivación a Urgencias genera Actualización relevante.
- ☐ Derivación exige documentar intento de llamada familiar sin retrasar la asistencia.
- ☐ Una publicación publicada no puede editarse.
- ☐ Un error ordinario se corrige mediante nueva publicación vinculada.
- ☐ Retirada excepcional exige causa y trazabilidad.
- ☐ Familia no accede a Historial clínico ni línea temporal.
- ☐ No existe chat.
- ☐ Familiar puede solicitar cita presencial.
- ☐ Solicitud de cita diferencia Enfermería / equipo médico.
- ☐ Solicitud de cita advierte que no constituye canal urgente.
- ☐ Familia no selecciona un profesional concreto.
- ☐ Citas utilizan estados estructurados y no mensajería libre.
- ☐ Profesional visible como «Equipo asistencial del centro».

- ☐ No existe botón de descarga específico.
- ☐ Interfaz funciona en ordenador, tableta y móvil.

11. Casos de prueba principales

Caso 1 - Comunicación diaria

Publicación aprobada -> queda programada -> llega hora configurada -> aparece automáticamente.

Caso 2 - Comunicación semanal

Publicación aprobada -> espera día/hora configurados -> publicación.

Caso 3 - Solo actualizaciones relevantes

No aparecen resúmenes ordinarios; sí comunicaciones relevantes aprobadas.

Caso 4 - Actualización relevante

Profesional la clasifica -> aprueba -> publicación sin esperar al resumen ordinario.

Caso 5 - Derivación urgente

Derivación -> asistencia continua -> publicación relevante -> llamada familiar documentada.

Caso 6 - Corrección

Publicación original -> detección de error -> nueva publicación correctora -> original permanece.

Caso 7 - Error de privacidad

Publicación equivocada -> retirada excepcional -> deja de mostrarse contenido -> referencia y auditoría permanecen.

Caso 8 - Solicitud de cita

Familiar solicita equipo médico -> centro propone fecha -> familiar acepta -> cita confirmada.

Caso 9 - Usuario con dos residentes

Selecciona cada residente y nunca mezcla publicaciones.

Caso 10 - Autorización revocada

Acceso previo -> Administración revoca -> nuevas consultas bloqueadas.

12. Pendientes trasladados fuera del wireframe

Estos puntos no impiden declarar cerrado el perfil funcional:

- Definir política jurídica definitiva de conservación/retención.
- Definir implementación productiva de autenticación y segundo factor.

- Definir en el wireframe Administración/Dirección qué perfil recibe y gestiona las solicitudes de cita.
- Definir qué usuario administrativo configura horarios y frecuencias.
- Validar con DPO/asesoría el circuito de contacto familiar urgente.
- Validar con centro piloto los criterios operativos de «Actualización relevante».
- Definir procedimiento de soporte y permisos para retirada excepcional.
- Validar accesibilidad y usabilidad con familiares reales antes de producción.
- Actualizar PRD y AGENTS.md con las decisiones cerradas en este documento.

13. Resultado funcional esperado

El familiar entra en un portal sencillo y privado, identifica inequívocamente al residente y consulta información específicamente redactada para él.

Las publicaciones ordinarias permiten seguimiento periódico sin llamadas repetitivas. Las Actualizaciones relevantes permiten destacar acontecimientos que requieren mayor conocimiento familiar. Las situaciones urgentes continúan dependiendo del circuito asistencial y del contacto directo, no del portal.

Cuando el familiar necesita una explicación más profunda, puede solicitar una cita presencial estructurada con Enfermería o el equipo médico sin convertir la plataforma en un sistema de chat.

Toda la complejidad asistencial permanece detrás del Portal Familiar: Auxiliar -> Enfermería -> Medicina cuando corresponda -> cierre -> texto familiar -> aprobación -> publicación.

Advertencia de uso

Este wireframe define el comportamiento funcional del prototipo. No constituye una historia clínica homologada, una EIPD, una validación jurídica, una política definitiva de conservación, una certificación de seguridad ni autorización para utilizar datos sanitarios reales.